BOZIB 3,5 mg/VIAL

Bortezomib

Composición:
Cada frasco ampolla contiene:
Bortezomib.....3.5 mg
Excipientes..... c.s.

Vía de administración:
Intravenosa y subcutánea

Indicaciones: Terapia combinada para el tratamiento del mieloma múltiple en pacientes que previamente no han recibido tratamiento. Tratamiento de mieloma múltiple en pacientes que han recibido cuando menos una terapia previa. Terapia combinada para el tratamiento con linfoma de células del manto en pacientes que previamente no han recibido tratamiento. Tratamiento con linfoma de células del manto en pacientes con recidiva.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al bortezomib, al boro o al manitol. Úsese con precaución cuando se administre concomitantemente con medicaciones asociadas a neuropatía periférica o hipotensión, en pacientes con historia de alergias o asma, en pacientes que presenten alteraciones hidroelectrolíticas o del balance acido base, en pacientes con disminución en el flujo hepático, hipotensión y deshidratación, mielo supresión o historia de neuropatía periférica o falla renal. Bortezomib no debe ser usado en niños y adolescentes, a raíz de la experiencia limitada actualmente disponible. Pacientes con enfermedad pulmonar infiltrativa difusa aguda y enfermedad pericardial.

Advertencias y precauciones: Hable con su médico antes de usar bortezomib si tiene alguna de las condiciones a continuación: valores bajos de glóbulos rojos o blancos. Problemas de sangrado y/o números bajos de plaquetas en su sangre. Diarrea, estreñimiento, nausea o vomito. Desmayo, mareo o aturdimiento en el pasado. Problemas de riñón. Deterioro hepático moderado a severo (es decir, problemas de hígado). Adormecimiento, hormigueo o dolor en las manos o pies (neuropatía) en algún momento en el pasado. Problemas con el corazón o con la presión sanguínea. Falta de aliento o tos. Usted tendrá que hacer pruebas de sangre regulares antes y durante el tratamiento con bortezomib, para verificar periódicamente sus conteos de células sanguíneas.

Reacciones adversas
Resumen del perfil de seguridad
Las reacciones adversas graves reportadas de manera poco frecuente durante el tratamiento con bortezomib incluyen insuficiencia cardíaca, síndrome de lisis tumoral, hipertensión pulmonar, síndrome de encefalopatía posterior reversible, enfermedad pulmonar infiltrativa difusa aguda y raras veces neuropatía autónoma.
Las reacciones adversas reportadas con mayor frecuencia durante el tratamiento con bortezomib son náusea, diarrea, estreñimiento, vómito, fatiga, pirexia, trombocitopenia, anemia, neutropenia, neuropatía periférica (incluyendo sensorial), cefalea, parestesia, pérdida del apetito, disnea, erupción, herpes zoster y mialgia.

Mieloma sin tratamiento previo:

Reacciones adversas en pacientes con mieloma múltiple sin tratamiento previo tratados con bortezomib (≥10%)						
Reacciones adversas	**Bortezomib, Melfalán y prednisona (N=340)**			**Melfalán y prednisona (N=337)**		
	Total	**Toxicidad grado 3**	**Toxicidad grado ≥4**	**Total**	**Toxicidad grado 3**	**Toxicidad grado ≥4**
Cardiovascular						
Hipertensión	13%	2%	<1%	7%	1%	0%
Hipotension	12%	1%	1%	3%	1%	1%
SNC						
Astenia	21%	6%	<1%	18%	3%	0%
Vértigo	16%	2%	**0%**	11%	<1%	0%
Fatiga	29%	7%	1%	26%	2%	0%
Cefalea	14%	1%	0%	10%	1%	0%
Insomnio	20%	<1%	0%	13%	0%	0%
Neuralgia	36%	8%	1%	1%	<1%	0%
Parestesia	13%	2%	0%	4%	0%	0%
Neuropatía periférica	47%	13%	1%	5%	0%	0%
Dermatológico						
Prurito	10%	1%	0%	5%	0%	0%
Erupción	19%	1%	0%	7%	<1%	0%
Trastornos GI						
Dolor abdominal	14%	2%	0%	7%	<1	0%
Dolor abdominal superior	12%	<1%	0%	9%	0%	0%
Estreñimiento	37%	1%	0%	16%	0%	0%
Diarrea	46%	7%	1%	17%	1%	0%
Dispepsia	11%	0%	0%	7%	0%	0%
Náusea	48%	4%	0%	28%	<1%	0%
Vómito	33%	4%	0%	16%	1%	0%
Hematológico/Limfático						
Anemia	43%	16%	3%	55%	20%	8%
leucopenia	33%	20%	3%	30%	16%	4%
Linfopenia	24%	14%	5%	17%	9%	2%
Neutropenia	49%	30%	10%	46%	23%	15%
Trombocitopenia	52%	20%	17%	47%	16%	14%
Metabólico/Nutricional						
Anorexia	23%	3%	<1%	10%	1%	0%
Edema periférico	20%	1%	0%	10%	0%	0%
Hipopotasemia	13%	6%	1%	7%	2%	1%
Musculoesquelético						
Artralgia	11%	1%	0%	15%	1%	<1%
Dolor de espalda	17%	3%	<1%	18%	3%	<1%
Dolor de huesos	11%	2%	<1%	10%	2%	0%
Dolor en las extremidades	14%	2%	0%	9%	1%	<1%

Respiratorio						
Bronquitis	13%	1%	0%	8%	1%	0%
Tos	21%	0%	0%	13%	1%	0%
Disnea	15%	3%	1%	13%	1%	1%
Nasofaringitis	11%	<1%	0%	8%	0%	0%
Neumonía	16%	5%	4%	11%	4%	3%
Varios						
Herpes zoster	13%	3%	0%	4%	2%	0%
Pirexia	29%	2%	1%	19%	2%	1%

Pacientes de mieloma múltiple en recaída:
Reacciones adversas frecuentes — entre los 331 pacientes tratados con bortezomib, las reacciones más frecuentes fueron en general condiciones de astenia (61%); diarrea, náuseas (57%); estreñimiento (42%); neuropatía periférica no clasificados en otra parte (36%); trastornos psiquiátricos, fiebre, trombocitopenia, vómitos (35%); anorexia, disminución del apetito (34%); disestesia, parestesia (27%); anemia, dolor de cabeza (26%); y tos (21%). Las reacciones adversas más frecuentes entre los 332 pacientes en el grupo de dexametasona fueron los trastornos psiquiátricos (49%), astenia (45%) insomnio (27%), anemia (22%), diarrea e infecciones de las vías respiratorias/pulmonares inferiores (cada 21%). El catorce por ciento de los pacientes experimentaron una reacción adversa de grado 4 en el brazo tratado con bortezomib; las toxicidades más frecuentes fueron trombocitopenia (4%), neutropenia (2%), y la hipercalcemia (2%). Dieciséis por ciento de los pacientes tratados con dexametasona experimentaron una reacción adversa de grado 4; La toxicidad más común era la hiperglucemia (2%).
Reacciones adversas graves - reacciones adversas graves se definen como cualquier evento, independientemente de la causalidad, que resulta en la muerte, es peligrosa para la vida, requiere hospitalización o prolonga la hospitalización actual, resulta en una incapacidad significativa, o se considera como un evento de importancia clínica. Cuarenta y cuatro por ciento de los pacientes del grupo con tratamiento bortezomib experimentó una reacción adversa severa durante el estudio, al igual que 43% de los pacientes con tratamiento de dexametasona. Las reacciones adversas graves más frecuentes en el brazo del tratamiento con bortezomib fueron pirexia (6%), diarrea (5%), disnea y neumonía el 4%, y vómitos (3%). En el grupo de tratamiento con dexametasona, las reacciones adversas graves más frecuentes fueron neumonía (7%), pirexia (4%), y la hiperglucemia (3%). Cuatro muertes fueron consideradas como relacionadas con el tratamiento de bortezomib en el estudio de fase 3: 1 caso cada uno de un paro cardíaco, shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca congestiva e insuficiencia respiratoria. Cuatro muertes se consideraron relacionadas con dexametasona: 2 casos de sepsis, 1 caso de meningitis bacteriana, y 1 caso de muerte súbita en casa.
Interrupción - Un total de 145 pacientes, incluyendo 25% de los pacientes del grupo de tratamiento con bortezomib y el 18% de los pacientes del grupo de tratamiento con dexametasona, interrumpieron el tratamiento debido a reacciones adversas relacionadas con el medicamento evaluadas por los investigadores. Entre los 331 pacientes tratados bortezomib, la reacción adversa relacionada con el medicamento reportado con mayor frecuencia que conllevó a la interrupción del tratamiento fue la neuropatía periférica (8%). Entre los 332 pacientes en el grupo de dexametasona, las reacciones relacionadas con el medicamento reportadas con mayor frecuencia que provocaron la interrupción del tratamiento fueron la hiperglucemia y el trastorno psicótico (cada uno del 2%).

Reacciones adversas más frecuentes (al menos 10%)

Reacciones adversas del tratamiento de bortezomib en pacientes de mieloma múltiple en recaída (≥10%)						
Reacciones adversass	**Bortezomib (N=331)**			**Dexametasona (N=332)**		
	Todas las reacciones	**Eventos grado 3**	**Eventos grado 4**	**Todas las reacciones**	**Eventos grado 3**	**Eventos grado 4**
	100%	**61%**	**14%**	**98%**	**44%**	**16%**

SNC						
Condiciones asténicas	61%	12%	<1%	45%	6%	0%
Mareo(excluyendo vértigo)	14%	<1%	0%	10%	0%	0%
Cefalea	26%	<1%	0%	13%	<1%	0%
Insomnio	18%	<1%	0%	27%	2%	0%
Parestesia y disestesia	27%	2%	0%	11%	<1%	0%
Neuropatía periférica	36%	7%	<1%	9%	<1%	<1%
Desórdenes Siquiátricos	35%	3%	<1%	49%	8%	<1%
GI						
Dolor abdominal	16%	2%	0%	4%	<1%	0%
Anorexia y pérdida del apetito	34%	3%	0%	9%	<1%	0%
Estreñimiento	42%	2%	0%	15%	1%	0%
Diarrea	67%	7%	0%	21%	2%	0%
Náusea	57%	2%	0%	14%	0%	0%
Vómito	35%	3%	0%	6%	1%	0%
Hematológico						
Anemia	26%	9%	<1%	22%	10%	<1%
Neutropenia	19%	12%	2%	2%	1%	0%
Trombocitopenia	35%	20%	4%	11%	5%	1%
Musculoesquelético						
Artralgia	14%	<1%	0%	11%	2%	0%
Dolor de espalda	14%	3%	0%	10%	1%	0%
Dolor de huesos	16%	4%	0%	15%	3%	0%
Calambres musculares	12%	0%	0%	15%	<1%	0%
Mialgia	12%	<1%	0%	5%	<1%	0%
Dolor en las extremidades	15%	2%	0%	7%	<1%	0%
Escalosfrios	11%	0%	0%	2%	0	0%
Respiratorio						
Tos	21%	<1%	0%	11%	<1%	0%
disnea	20%	5%	<1%	17%	3%	<1%
Infecciones del tracto respiratorio inferior/pulmón	15%	4%	<1%	21%	7%	<1%
Nasofaringitis	14%	<1%	0%	7%	0%	0%
Varios						
Edema de miembros inferiores	11%	0%	0%	13%	<1%	0%
Herpes zoster	13%	2%	0%	5%	1%	<1%
Pirexia	35%	2%	0%	16%	1%	<1%
Erupción	16%	1%	0%	6%	0%	0%

Resumen completo de seguridad (del mieloma múltiple en recaída y linfoma de células del manto:

Reacciones adversas más frecuentes - En el análisis integrado, las reacciones adversas reportadas con mayor frecuencia fueron astenia (incluyendo fatiga, malestar y debilidad) (64%), náuseas (55%), diarrea

(52%), estreñimiento (41%), neuropatía periférica no clasificados en otra parte (incluyendo La neuropatía sensorial periférica y neuropatía periférica agravada) (39%), disminución del apetito (incluyendo anorexia) y trombocitopenia (36%), pirexia (34%), vómitos (33%), y la anemia (29%). El veinte por ciento de pacientes experimentaron al menos 1 episodio de toxicidad de al menos grado 4, más frecuente trombocitopenia (5%) y neutropenia (3%).

Reacciones adversas graves - Un total de 50% de los pacientes experimentaron reacciones adversas graves durante los estudios. Las reacciones adversas graves más frecuentes incluyen la neumonía (7%); pirexia (6%); diarrea (5%); vómitos (4%); deshidratación, disnea, náuseas y trombocitopenia (3%).
En total, el 2% de los pacientes murió. Las causas de muerte consideradas por el investigador como posiblemente relacionadas con los medicamentos del estudio incluyen reportes de paro cardíaco, insuficiencia cardíaca congestiva, neumonía, insuficiencia renal, fallo respiratorio y sepsis.

Interrupción — Las reacciones adversas que el investigador consideró estar relacionadas con los medicamentos y que provocaron la interrupción del tratamiento se produjo en el 22% de los pacientes. Las razones para la interrupción incluyen neuropatía periférica (8%), astenia (3%), y la diarrea y trombocitopenia (2%).

Reacciones adversas más frecuentes (al menos 10%)

Reacciones adversas de bortezomib a partir de un análisis integrado de estudios de mieloma múltiple en recaída y de linfoma de células del manto (≥10% en total)						
Reacciones adversas	Todos los pacientes (n=1163)		Mieloma múltiple (n=1008)		Linfoma de células del manto (n=155)	
	Todas las reacciones	Grado **≥3**	Todas las reacciones	Grado **≥3**	Todas las reacciones	Grado **≥3**
SNC						
Anxiedad	10%	<1%	11%	<1%	5%	0%
Condiciones asténicas	64%	16%	62%	16%	72%	19%
Marea excluyendo Vértigo	17%	2%	16%	1%	23%	3%
Cefalea	22%	1%	23%	2%	17%	0%
Insomnio	20%	<1%	20%	<1%	21%	<1%
Parestesia y Disestesia	22%	1%	24%	1%	9%	1%
Neuropatía periférica	39%	12%	37%	11%	55%	13%
GI						
Dolor abdominal	15%	3%	14%	2%	15%	5%
Pérdida del apetito	36%	3%	35%	2%	39%	3%
Estreñimiento	41%	2%	40%	2%	50%	3%
Diarrea	52%	8%	53%	8%	47%	7%
Náusea	55%	4%	57%	4%	44%	3%
Vómito	33%	5%	34%	5%	27%	3%
Hematológico						
Anemia	29%	11%	30%	12%	17%	3%
Neutropenia	17%	12%	18%	14%	6%	4%
Trombocitopenia	36%	29%	38%	32%	21%	11%
Metabolismo y nutrición						
Deshidratación	10%	3%	11%	3%	7%	5%
Edema	23%	<1%	22%	<1%	28%	3%
Musculoesquelético						

Artralgia	17%	2%	18%	2%	13%	1%
Dolor de espalda	13%	3%	15%	4%	<1%	0%
Calambres musculares	11%	<1%	12%	<1%	5%	0%
Mialgia	12%	<1%	12%	<1%	10 %	0%
Dolor linfático	15%	3%	17%	4%	5%	0%
Respiratorio						
Tos	20%	<1%	20%	<1%	19%	0%
Disnea	21%	5%	21%	5%	23%	5%
Nasofaringitis	12%	<1%	13%	<1%	8%	0%
Neumonía	12%	6%	12%	6%	9%	5%
Infecciones de las vías respiratorias superiores	12%	<1%	11%	<1%	15%	<1%
Varios						
Herpes zoster	12%	2%	13%	2%	9%	<1%
Hipotensión	13%	3%	12%	3%	15%	3%
Pirexia	34%	3%	37%	3%	19%	1%
Erupción	18%	<1%	17%	<1%	28%	3%

Mieloma múltiple en recaída y estudios fase 2 del linfoma de células del manto

GI: Un total de 87% de los pacientes experimentaron al menos un trastorno gastrointestinal. Los trastornos gastrointestinales más comunes incluyen estreñimiento, disminución del apetito, diarrea, náuseas y vómitos. Otros trastornos gastrointestinales incluyen dispepsia y disgeusia. Las reacciones gastrointestinales Grado 3 ocurrieron en el 18% de los pacientes; eventos grado 4 ocurrieron en 1% de los pacientes. Los eventos GI se consideraron graves en el 11% de los pacientes. El cinco por ciento de los pacientes interrumpieron el tratamiento debido a una reacción gastrointestinal. Se reportó con mayor frecuencia náuseas en pacientes con mieloma múltiple (57%) en comparación con los pacientes con linfoma de células del manto (44%).

Trombocitopenia: A través de los estudios, la trombocitopenia asociada con bortezomib se caracterizó por una disminución en el recuento de plaquetas durante el período de dosificación (días 1 a 11) y un retorno hacia la línea de base durante el período de descanso de 10 días durante cada ciclo de tratamiento. En general, se reportó trombocitopenia en el 36% de los pacientes. La trombocitopenia fue de grado 3 en el 24%, grado 4 o superior en un 5%, y grave en un 3% de los pacientes, y la reacción fue necesaria la interrupción bortezomib en el 2% de los pacientes. La trombocitopenia se reportó con mayor frecuencia en pacientes con mieloma múltiple (38%) en comparación con los pacientes con linfoma de células del manto (21%). La incidencia de trombocitopenia de grado 3 o superior también fue mayor en los pacientes con mieloma múltiple (32%) en comparación con los pacientes con linfoma de células del manto (11%).

Neuropatía periférica: En general, la neuropatía periférica no clasificada en otra parte se produjo en el 39% de los pacientes. La neuropatía periférica de grado 3 en el 11% de los pacientes y de grado 4 en al menos el 1% de los pacientes. El ocho por ciento de los pacientes interrumpieron el bortezomib debido a neuropatía periférica. La incidencia de la neuropatía periférica fue mayor entre los pacientes con linfoma de células del manto (55%) en comparación con los pacientes con mieloma múltiple (37%).

En el estudio de mieloma múltiple en recaída, entre los 87 pacientes que experimentaron neuropatía periférica de grado 2 o superior, el 51% había mejorado o resuelto dentro de una mediana de 3.5 meses desde la primera aparición.

Entre los pacientes con neuropatía periférica en estudios fase 2 de múltiple mieloma que eran grado 2 y provocaron la interrupción del tratamiento o fue de grado 3 o superior, el 73% reportó mejoría o resolución tras ajustar la dosis de bortezomib, con un tiempo medio de mejoría de 1 grado o más desde la última dosis de bortezomib de 33 días.

Hipotensión:

La incidencia de hipotensión (hipotensión postural, hipotensión ortostática, e hipotensión no especificada de otro modo) fue del 13% en los pacientes tratados con bortezomib. La hipotensión

fue de grado 1 o 2 en la mayoría de los pacientes grado 3 en 3%, y grado 4 o superior en menos del 1% de los pacientes. El 3% por ciento de los pacientes reportó hipotensión como una reacción adversa grave, y el 1% interrumpió el tratamiento a causa de la hipotensión. El incidencia de hipotensión fue similar en pacientes con mieloma múltiple (12%) y el linfoma de células del manto (15%). Además, el 2% de los pacientes que experimentaron hipotensión tenían un evento de síncope. La dosis de medicamentos antihipertensivos deben ser ajustados en pacientes en tratamiento con bortezomib.
Neutropenia: El recuento de neutrófilos disminuyó durante el período de dosificación de bortezomib, (día 1-11) y regresó al nivel base durante el período de descanso de 10 días, durante cada ciclo de tratamiento. En general la neutropenia ocurrió en el 17% de los pacientes, fue grado 3 en el 9% de los pacientes, y grado 4 o superior en 3% de los pacientes. La neutropenia se reportó como reacción grave en menos del 1% de los pacientes, y menos del 1% de los pacientes interrumpieron el tratamiento debido a neutropenia. La incidencia de neutropenia fue mayor en los pacientes con mieloma múltiple (18%) en comparación con los pacientes con linfoma de células del manto (6%). La incidencia de neutropenia grado 3 o superior también fue mayor en los pacientes con mieloma múltiple (16%) en comparación con los pacientes con linfoma de células del manto (4%).
Condiciones asténicas: las condiciones asténicas como la fatiga, malestar, debilidad se reportaron en el 64% de los pacientes. La astenia fue grado 3 para el 16% y grado 4 o superior en menos del 1% de los pacientes. El 4% de los pacientes interrumpieron el tratamiento debido a la astenia. Las condiciones asténicas se reportaron en el 62% de los pacientes con mieloma múltiple y en el 72% con linfoma de células del manto.
Pirexia: Pirexia (mayor de 38 grados C [100.4 ° F]) fue reportada como reacción adversa por el 34% de los pacientes. La reacción fue grado 3 en el 3% y grado 4 o superior en menos del 1% de los pacientes. Pirexia fue reportada como una reacción adversa grave en el 6% de los pacientes y provocó la interrupción del tratamiento con bortezomib en menos del 1% de los pacientes. La incidencia de pirexia fue mayor entre los pacientes con mieloma múltiple (37%) en comparación con los pacientes con linfoma de células del manto (19%). La incidencia de pirexia grado 3 o superior fue del 3% en los pacientes con mieloma múltiple y del 1% en pacientes con linfoma de células del manto.
***Infección por el virus del herpes*:** Considere el uso de la profilaxis antiviral en sujetos que están siendo tratados con bortezomib. En los estudios aleatorios de mieloma múltiple en recaída y sin tratamiento previo, la reactivación del herpes zoster fue más frecuente en los sujetos tratados con bortezomib (13%) que en los grupos de control (4% a 5%). El herpes simple se observó en 2% a 8% de los sujetos tratados con bortezomib y 1% a 5% en los grupos de control. En el estudio de mieloma múltiple sin tratamiento previo, la reactivación del virus herpes zoster en pacientes con tratamiento de bortezomib, melfalán, y prednisona fue menos frecuente en los sujetos que recibieron la terapia antiviral profiláctica (3%) que en los sujetos que no recibieron terapia antiviral profiláctica (17%.).

Reacciones adversas graves adicionales:
Cardiovascular - La angina de pecho, fibrilación auricular agravada, aleteo auricular, bradicardia, amiloidosis cardíaca, hemorragia cerebral, accidente cerebro vascular, bloqueo auriculoventricular completo, trombosis venosa profunda, accidente cerebrovascular hemorrágico, infarto de miocardio, isquemia de miocardio, derrame pericárdico, pericarditis, embolia periférica, embolia pulmonar, hipertensión pulmonar, paro sinusal, *torsade de points*, ataque isquémico transitorio, taquicardia ventricular.
SNC – Aagitación, ataxia, coma, confusión, parálisis craneal, disartria, disautonomía, encefalopatía, Convulsión tónico-clónica generalizada, cambio del estado mental, disfunción motora, neuralgias, parálisis, neuralgia post terapéutica * trastorno psicótico, RPLs compresión de la médula espinal , ideación suicida, vértigo.
Dermatológico - *vasculitis leucocitoclástica,* erupción cutánea (puede ser pruriginosa), urticaria.
GI – Ascitis, disfagia, impactación fecal, gastritis, hemorrágica, gastroenteritis, reflujo gastroesofágico, hematoemesis, duodenitis hemorrágica, íleo paralítico, obstrucción intestinal amplia, perforación intestinal amplia, melena, petequias en la mucosa oral, pancreatitis aguda, obstrucción intestinal paralítica, peritonitis, obstrucción del intestino delgado, estomatitis.

GU- Insuficiencia renal crónica y aguda, hidronefrosis bilateral, espasmos de la vejiga, hematuria, cistitis hemorrágica, nefritis glomerular proliferativa, cálculos renales, incontinencia urinaria, retención urinaria, infección del tracto urinario.
Hematológico/Linfático - Coagulación intravascular diseminada, leucopenia, linfopenia.
Hepático – Colestasis, hemorragia hepática, hepatitis, insuficiencia hepática, hiperbilirrubinemia, trombosis de la vena porta.
Hipersensibilidad - Reacción anafiláctica, angioedema, hipersensibilidad a fármacos, y la hipersensibilidad mediada por complejos inmunes.
Local – Eritema en el sitio de la inyección, dolor en el sitio de la inyección, irritación, flebitis.
Metabólico/Nutrcional*:* Hiperpotasemia, hiponatremia, hiperuricemia, hipocalcemia, hipopotasemia, hipernatremia.
Respiratorio - Síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), neumonía por aspiración, atelectasia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica exacerbada, disnea, disnea de esfuerzo, epistaxis, hemoptisis, hipoxia, infiltración pulmonar, derrame pleural, neumonía, dificultad respiratoria, y sinusitis.
Sentidos especiales - Infección conjuntival, diplopía y visión borrosa, irritación de los ojos, problemas de audición.
Varios: Aspergilosis, bacteriemia, complicación relacionada con el catéter, infección por catéter acoplado, edema facial, infecciones virales por herpes, edema laríngeo, listeriasis, candidiasis oral, shock séptico, fractura ósea, hematoma subdural, toxoplasmosis.
Post-comercialización:
Cardiovascular - Bloqueo auriculoventricular completo, taponamiento cardíaco, coagulación intravascular diseminada.
SNC: Disautonomía, encefalopatía, el herpes. Meningoencefalitis. (ii – pancreatitis aguda, hepatitis, colitis isquémica).
Sentidos especiales: sordera bilateral, herpes oftálmico.

Sobredosificación
En los pacientes, la sobredosis de más de dos veces la dosis recomendada se ha asociado con la aparición aguda de hipotensión sintomática y trombocitopenia con desenlace fatal. No se conoce un antídoto específico para la sobredosis de bortezomib. En caso de sobredosis, los signos vitales del paciente deben ser controlados y un cuidado de soporte apropiado para mantener la presión arterial (como líquidos, compresores, y/o agentes inotrópicos) y la temperatura corporal.

IPPab V00 Jul 2016